

УДК: 616-006.6:615.277

¹Н.Т.Балтабеков, ^{1,2}К.Ш.Нургазиев, ²А.К.Туманова, ²Ш.Ж.Талаева, ²А.Я.Тогызбаева.¹Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,²Казахский НИИ онкологии и радиологии

Профилактика осложнений базисной терапии и медицинская реабилитация с использованием надерина при социально значимых заболеваниях, включая злокачественные новообразования, туберкулез и гепатит С. Грант КазНМУ 2013.

Аннотация. Работа посвящена профилактике гематологических осложнений при социально значимых заболеваниях, включая туберкулез, гепатит С и злокачественные новообразования за счет использования надерина (нуклеаната натрия) под контролем иммунограммы.

Ключевые слова: меланома, интерферон альфа, надерин

Актуальность

Злокачественные новообразования, туберкулез, вирусный гепатит С относятся к социально значимым заболеваниям в связи с высоким уровнем инвалидизации и смертности.

К осложнениям, возникающим в процессе лечения данной группы пациентов относятся лейкопения, тромбоцитопения и вторичный клеточный иммунодефицит, кардио и гепатотоксичность.

Наличие данных осложнений является причиной резкого ухудшения качества жизни больных, приводит к прогрессированию основного заболевания и значительно ухудшает прогноз.

Важным моментом является тот факт, что существующий на сегодняшний день стандартные методы борьбы с этими осложнениями являются очень дорогостоящими, токсичными, обладающие кратковременным действием и не нашедшие широкого применения в практической медицине.

В поле зрения ученых-медиков Казахстана попал иммуномодулирующий препарат на базе DNA-Na (деринат натрия), «Naderun» производства Италии

При апробации которого в совместных пилотных Италияно - Казахстанских исследованиях 2007-2010 годов в клиниках Университетской многопрофильной больницы г.Брешия ,регион Ламброджия, Италия (М.Чезаре, А.Ферарри), и Городского Онкологического Диспансера г.Алматы, Казахстан, были получены обнадеживающие результаты использования надерина для профилактики лейкопении ,инфекционных осложнений при лекарственной противоопухолевой терапии рака молочной железы , меланоме кожи ,рака почки и колоректальном раке.(Н.Т. Балтабеков , Люмузова Г.Г., Пазылов Ш.Т.2010г)

В Италии данный препарат считается парфармацевтическим средством. Однако, серьезность применения данного препарата в онкологии, хирургии, кардиологии, иммунологии и пр., явно недооценена.

В процессе совместных многоцентровых исследований

с участием экспертной группы ЕАФО (А.Эгермонт, Франция, Л.В.Демидов, Россия, С.Агарвала, США, Сомасундарап, Индия) по определению эффективности надерина для профилактики осложнений противоопухолевой терапии было выявлено ряд положительных моментов.

Так надерин существенно снижает чувствительность клеток к повреждающему действию цитотоксических препаратов, что проявляется в снижении миелотоксичности у онкологических больных и стабильности терапевтического эффекта повторных курсов лечения. Препарат обладает высоким репаративным и регенераторным действием.

При добавлении надерина в комплексную терапию, при наличии сопутствующей патологии со стороны сердечно сосудистой системы, при ИБС и сердечной недостаточности улучшается сократительная функция миокарда, предотвращается гибель миоцитов, повышается толерантность к физической нагрузке.

Предпосылки к разработке

По литературным данным (Мирошник О.А. 2002 год) активное использование иммунотерапии началось в семидесятых годах XX в., когда получила признание иммунологическая теория происхождения злокачественных опухолей и была продемонстрирована возможность восстановления иммунологических показателей у онкологических больных при использовании ряда препаратов (Мирошник О.А. 2002 г.).

В 2002 г. во Франции в городе Канн на VIII Международном конгрессе по иммунореабилитации В.П.Кузнецов высказал мнение, что не смотря на более 30-летний опыт использования самостоятельной иммунотерапии в онкологии наиболее перспективным направлением является совместное использование базисной противоопухолевой терапии и иммунопрепаратов как вспомогательного компонента для улучшения переносимости противоопухолевой химио- или лучевой терапии, а также повышение качества жизни больных.

Так О.А.Мирошник считает что иммунологическое обследование и первичную иммунокоррекцию необходимо проводить у каждого онкологического больного, получающего химио- или лучевую терапию.

По мнению автора, противоопухолевое лечение подавляет иммунитет больного и требует пожизненного мониторинга состояния иммунной системы и его соответствующей коррекции.

Принципиальные отличия данного проекта от предыдущих

Впервые будет определена эффективность дополнительной иммунокоррекции с учетом иммунологического статуса у пациентов с туберкулезом, гепатитом В и злокачественными новообразованиями и в качестве иммунокорректирующего препарата в онкологии, фтизиатрии и гепатологии будет использоваться низко молекулярные натрий содержащие соли нуклеиновых кислот надерин вместо стандартных колониостимулирующих факторов.

Материал и методы исследования

Предварительные результаты в группе больных раком молочной железы (РМЖ) у 12 пациенток, во 2 «Б» стадии, получавших неoadъювантную химиотерапию по схеме «АС», в условиях маммологического отделения КазНИИ Онкологии и Радиологии с июня по октябрь 2014 года показывают высокую эффективность и снижение токсичности химиотерапии по сравнению с контрольной группой- 10 пациенток (РМЖ) не получавших надерин при стандартных курсах противоопухолевой химиотерапии.

При исследовании иммунологического статуса у онкологических больных с раком молочной железы, проведенных в лаборатории иммунодиагностики КазНИИОиР, как в основной, так и в контрольной группах отмечено снижение у иммунорегуляторного индекса у 75 % обследованных больных в среднем на 25% от нормы.

Выявлено как клинически, так и по данным анализов крови, повышение иммунного статуса (CD4/CD8), улучшение общего самочувствия, снижение опухолевой активности (РЭА) в основной группе, статистическая обработка достоверности различий в основной и контрольной группах не проводилась из-за малого количества наблюдений и будет предоставлена после окончания исследования.

Дополнительно выявлено, что у пациентов в основной группе РМЖ, значительно снижена кардиотоксичность, что подтверждено результатами эхокардиографии у 3 пациенток с сопутствующим постинфарктным кардиосклероз. При этом дополнительное использование надерина при химиотерапии по кардиотоксичной схеме «АС» не только не ухудшило показатели фракции систолического выброса но и улучшило в среднем на 8.5 %.

Таким образом, полученные в ходе научного исследования данные, несмотря на их малое количество и низкую статистическую достоверность, подтверждают результаты пилотного Итальяно-Казахстанского исследования 2007 года.

Выводы

1. Иммунодефицит значительно ухудшает прогноз лечения, а также качество жизни пациентов со злокачественными образованиями.

2. Для проведения иммунокоррекции необходим четкий контроль за состоянием иммунологического статуса в процессе базисного лечения с целью своевременной профилактики возможных осложнений,

3. Назначение иммунопрепаратов, без определения иммунологического статуса не эффективно и опасно и может навредить больному, вызвать или аллергическую реакцию или прогрессирование опухолевого процесса.

3. Применение надерина при химиотерапии по схеме «АС» РМЖ, под контролем иммунограммы, позволяет повысить эффективность базисной терапии, снизить ток-

сичность противоопухолевого лечения и повысить качество жизни пролеченных больных

4. Использование надерина при наличии сопутствующей патологии со стороны сердечно сосудистой системы и наличии сердечной недостаточности улучшает сократительную функцию миокарда, повышается толерантность к физической нагрузке и воздействию кардиотоксичной противоопухолевой терапии

5. Внедрение в практику надерина позволяет снизить затраты на иммунокорректирующую терапию почти в семь раз по сравнению с существующими схемами иммунокоррекции Казахстана и Европейской ассоциации онкологов.

Список литературы

1. Балтабеков Н.Т. Новые подходы к адъювантной иммунотерапии интерферона альфа в сочетании с надерином в онкологической практике //Мат. 8 съезда онкологов стран Евразии и стран СНГ.-Казань, 2014.
2. Балтабеков Н.Т. Медицинская реабилитация при социально значимых заболеваниях //Мат.Международной Казахстанско Итальянской конф. «Актуальные вопросы медицинской реабилитации».-Алматы, 2014.
3. Балтабеков Р.Т. Актуальные вопросы диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных //Мат. международного конгресса по эстетической медицине и пластической хирургии.- Алматы, 2014.

Тұжырым

Н. Т. Балтабеков, Қ. Ш. Нұрғазиев, А.Қ.Туманова,Ш.Ж.Талаева, А.Я.Тогызбаева

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Қатерлі ісік, туберкулез және гепатит С, соның ішінде әлеуметтік маңызды ауруларды емдеуде надеринды пайдаланып, негізгі терапия және медициналық оңалту асқынулардың алдын алу үшін арналған.

Қазақтың Ұлттық медицина университетінің 2013 гранты

Бұл жұмыс иммунограмманы бақылау арқылы қатерлі ісік, туберкулез және гепатит С, соның ішінде әлеуметтік маңызды ауруларды емдеуде надеринды (натрий нуклеанаты) пайдаланып гематологиялық асқынулардың алдын алу үшін арналған.

Түйінді сөздер: асқынулар, алдын алу, оңалту, надерин.

Summary

N. T. Baltabekov, K. S. Nurgaziyev, A. K. Tumanova, S. Z. Talaeva, A. Y. Togyzbaeva

Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

Kazakh National Medical University im. S. D. Asfendiyarova
Prevention of complications of basic therapy and medical rehabilitation using naderine in socially significant diseases, including cancer, tuberculosis and hepatitis C.

Grant KazNMU 2013

The work is dedicated to the prevention of hematological complications of socially significant diseases, including tuberculosis, hepatitis C and malignant tumors by using naderine (sodium nukleanat) under the control immunograms.

Keywords: complications, prevention, rehabilitation, naderine.